

Razonamiento clínico — Dedos

bodyPart: finger · entry: fg_master_entry

Árbol interactivo de razonamiento clínico (Physioguide / AIKinora). Uso educativo para fisioterapeutas. No sustituye valoración presencial.

Nodos totales: 6

Entrada alternativa por test del informe

- **tinel** → fg_tinel
- **phalen** → fg_phalen

Flujo de nodos (desde la entrada)

1. [CONCLUSIÓN] Dedos — enrutado Physioguide

id: fg_master_entry

Resumen: Flujo: ¿parestias medianas/nocturnas? → cribado STC (Phalen/Tinel apoyan, no confirman). Sin neural → patología digital local. Meñique solo ≠ STC.

Hipótesis:

- **Enrutar neural vs local** (alta) — Noche + 1.º–3.º → STC ↑. Bloqueo/chasquido dedo → A1/local.
- Continúa en: **fg_neural_gate**

2. [TEST / GATE] ¿Hormigueo tipo túnel carpiano?

id: fg_neural_gate

testId: route-finger-neural

Descripción: Noche, sacudir la mano, 1.º–3.º dedos → rama STC. Solo dolor/bloqueo mecánico del dedo → local.

Procedimiento: Enrutado clínico.

- **Positivo / Sí:** Parestias nocturnas / territorio mediano → **fg_cts_cluster**
- **Negativo / No:** Sin cuadro neural dominante → **fg_pulley**

3. [CONCLUSIÓN] Compatible con STC (síntomas digitales)

id: fg_cts_cluster

Resumen: Historia nocturna + territorio mediano. Phalen/Tinel apoyan el cluster; negativos no descartan. Cribar cervical.

Hipótesis:

- **Túnel carpiano (STC)** (alta) — Patrón de parestias medianas.
 - **Referido cervical** (media) — Si cuello o territorio atípico.
- Continúa en: **fg_tinel**

4. [CONCLUSIÓN] Compatible con patología digital local

id: fg_pulley

Resumen: Sin neuropatía mediana dominante; valorar trigger/A1, esguince IF o UCL pulgar según mecanismo.

Hipótesis:

- **Trigger finger / tenosinovitis A1** (alta) — Chasquido o bloqueo en flexión.
 - **Esguince interfalángico / UCL pulgar** (media) — Trauma o inestabilidad del pulgar.
- Nodo terminal (fin de rama).

5. [TEST / GATE] Signo de Tinel

id: fg_tinel

testId: tinel

Descripción: Percusión sobre el nervio mediano en el túnel carpiano.

Procedimiento: Percusión sobre el nervio mediano en el túnel carpiano.

Evidencia: Complemento de Phalen (a menudo menos sensible que la historia nocturna). Parestesias en territorio mediano, no dolor local. No confirma STC solo.

→ **Positivo / Sí:** Parestesias medianas familiares → **fg_cts_cluster**

→ **Negativo / No:** Tinel no familiar → **fg_phalen**

6. [TEST / GATE] Test de Phalen

id: fg_phalen

testId: phalen

Descripción: Flexión máxima de muñeca sostenida 60 s (posición de rezo).

Procedimiento: Flexión máxima de muñeca sostenida 60 s (posición de rezo).

Evidencia: D'Arcy & McGee JAMA 2000; JOSPT CTS CPG 2019: precisión moderada/mixta. Cluster (noche, sacudir la mano) > Phalen aislado. Negativo no descarta.

→ **Positivo / Sí:** Phalen familiar → **fg_cts_cluster**

→ **Negativo / No:** Phalen no familiar → **fg_pulley**